

Dissection de l'Aorte

Pr RABEARIVONY Nirina
Cardiologue

Plan

Introduction

1- Signes

11- Type de description

12- Formes cliniques

2- Diagnostic

21- Positif

22- Différentiel

3- Traitement

31- Buts

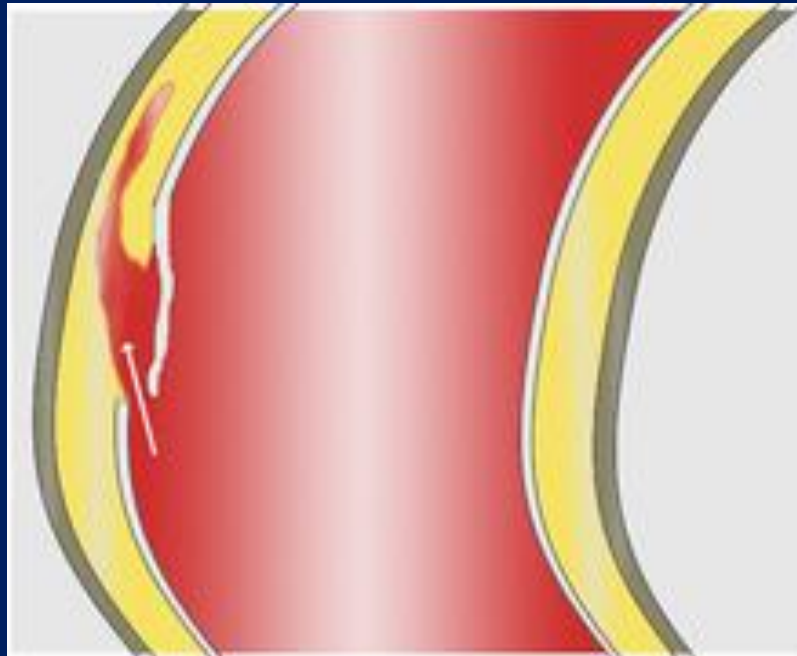
32- Moyens

33- Indications

Conclusion

Introduction

- Définition
 - Clivage (fissuration) longitudinal de la paroi AO à partir d'une porte d'entrée (déchirure) intimale entraînant la création d'un faux chenal d'extension variable



Introduction

- **Intérêts**
 - **Urgence médico-chirurgicale engageant le pronostic vital du patient à court terme (50 % de décès dans les 48 h)**

1-Signes

11- Type de description:

Dissection aiguë de l'AO ascendante

111- Circonstances de découverte

- Douleur thoracique +++

112- Signes cliniques

- Douleur:

- ~ aiguë, brutale (« coup de couteau »)
- ~ thoracique, antérieure, large, irradiant entre les omoplates (quelquefois cou, mâchoires, bras)
- ~ sévère, intense, atroce (syncopale)

1-Signes

11- Type de description:

Dissection aiguë de l'AO ascendante

112- Signes cliniques

- **Douleur:**

- ~ pulsatile, cyclique, (associée aux battements cardiaques)

- ~ migratrice (poitrine, dos, omoplates, abdomino-lombaire, M Inf)

1-Signes

11- Type de description:

Dissection aiguë de l'AO ascendante

112- Signes cliniques

→ **obstruction du vrai chenal par la compression d'un faux chenal en tension**

- **Asymétrie pouls, tensionnelle** (aux M sup)
 - anisosphygme
 - anisotension

1-Signes

11- Type de description:

Dissection aiguë de l'AO ascendante

112- Signes cliniques

→ **obstruction totale du courant circulatoire dans un territoire**

- **Ischémie de membre (s)**

- à bascule, d'intensité variable dans le temps

- **Déficit neurologique** (atteinte cérébrale, médullaire)

- AIT, AVC, paraplégie

1-Signes

11- Type de description:

Dissection aiguë de l'AO ascendante

112- Signes cliniques

- **Oligo-anurie** (atteinte des artères rénales)
- **Douleurs abdominales** (ischémie digestive)

1-Signes

11- Type de description:

Dissection aiguë de l'AO ascendante

112- Signes cliniques

- **Collapsus:**

- / perte volémique dans le faux chenal ou les tissus péri-aortiques
 - / tamponnade péricardique

- **Souffle diastolique d'IA**

- ~ évocatrice si non connue dans les atcd

1-Signes

11- Type de description:

Dissection aiguë de l'AO ascendante

113- Signes paracliniques

- **ECG:**

- ~ normal

- ~ signes d'ischémie ou de nécrose myocardique (atteinte des ostia coronaires par la dissection)

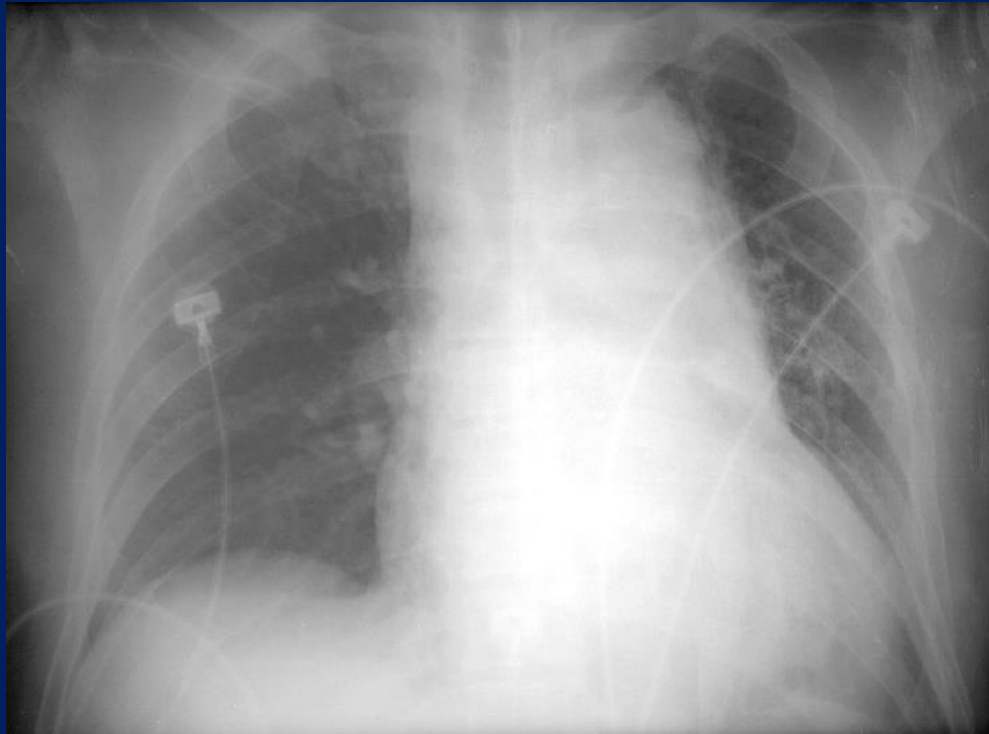
1-Signes

11- Type de description:

Dissection aiguë de l'AO ascendante

113- Signes paracliniques

- **Radio thoracique** → élargissement du médiastin



1-Signes

11- Type de description:

Dissection aiguë de l'AO ascendante

113- Signes paracliniques

- **Echodoppler cardiaque (ETO)**
 - « **voile intimal** » mobile dans la lumière aortique
 - précise la porte d'entrée dans 80%
 - apprécie l'extension de la dissection
 - quantifie une éventuelle IA
 - détecte un épanchement péricardique
 - sensibilité 99 % ; spécificité 98 %

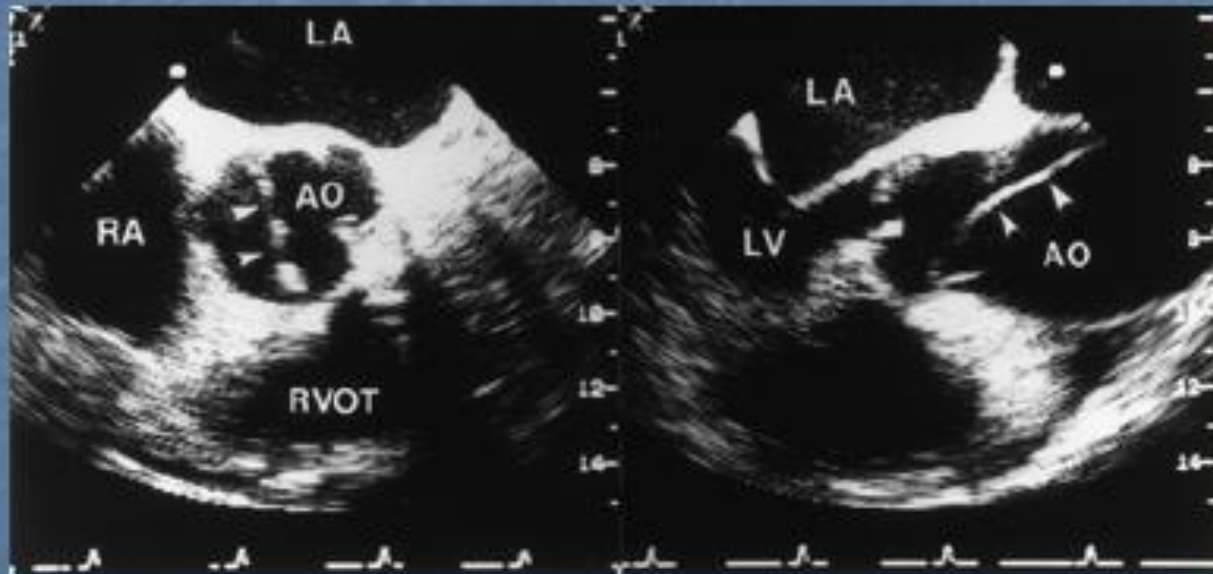
1-Signes

11- Type de description:

Dissection aiguë de l'AO ascendante

113- Signes paracliniques

ETO



1-Signes

11- Type de description:

Dissection aiguë de l'AO ascendante

113- Signes paracliniques

- **Angioscanner thoraco-abdominal**
 - membrane flottante
 - opacification différente du vrai et du faux chenal
 - apprécie l'extension de la dissection
 - détecte un épanchement péricardique

1-Signes

11- Type de description:

Dissection aiguë de l'AO ascendante

113- Signes paracliniques

TDM



1-Signes

11- Type de description:

Dissection aiguë de l'AO ascendante

113- Signes paracliniques

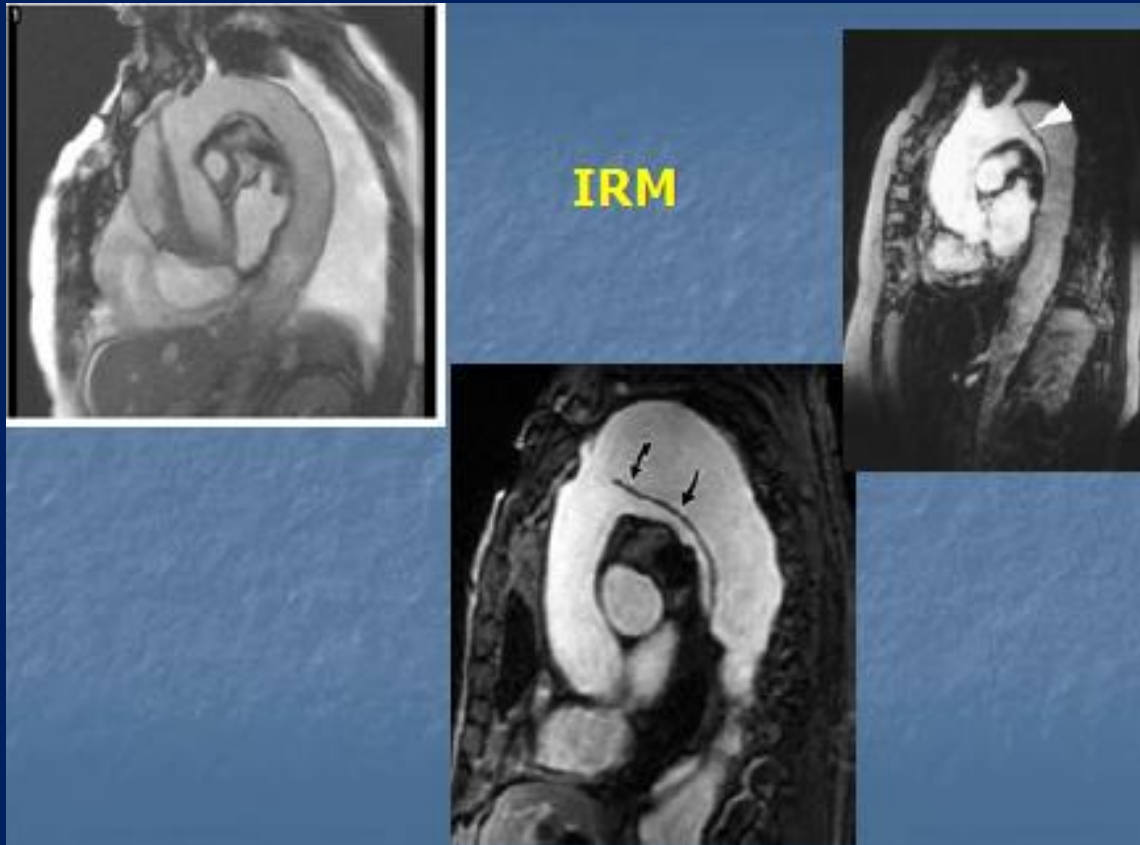
- IRM, Angio-IRM
 - meilleur examen morphologique
 - étudie l'orifice d'entrée, de sortie et l'extension
 - inconvénient: longueur de la procédure, manque de disponibilité en urgence

1-Signes

11- Type de description:

Dissection aiguë de l'AO ascendante

113- Signes paracliniques



1-Signes

11- Type de description:

Dissection aiguë de l'AO ascendante

113- Signes paracliniques

- artériographie:
 - n'est plus utilisée
 - dangereuse

1-Signes

11- Type de description:

Dissection aiguë de l'AO ascendante

114- Evolution

- spontanée:
 - risque de rupture +++
 - nombre de patients arrivant vivants à l'hôpital < 50 %
 - 100 % des patients non opérés décèdent en 48 h
- après traitement chirurgical
 - bon pronostic

1-Signes

11- Type de description:

Dissection aiguë de l'AO ascendante

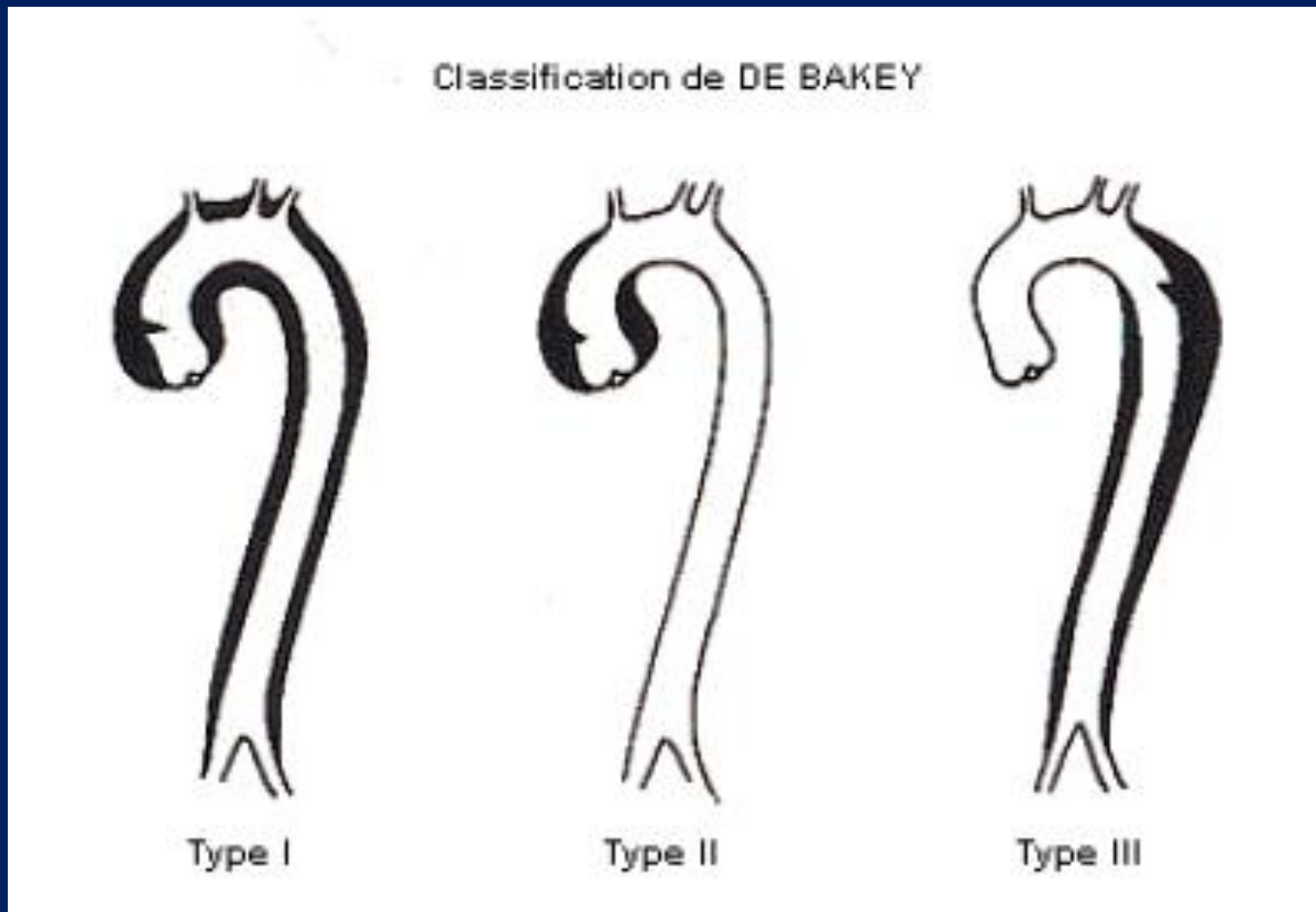
115- Complications

- rupture (hémopéricarde, hémomédiastin)
- extension en amont
 - atteinte coronaire (IDM)
 - anneau aortique (IA)
- extension en aval
 - ischémie périphérique (rénale, digestive)
- passage à la chronicité (hématome intra-pariétal)

1-Signes

12- Formes cliniques

121- Formes topographiques (classification)



1-Signes

12- Formes cliniques

121- Formes selon le terrain:

- HTA
- Maladie de MARFAN
- Atcd

familiaux de dissection

anévrisme de l'AO ascendante connu

bicuspidie AO

réparation de coarctation de l'AO

- 3^{ème} trimestre de grossesse ou post-partum

2- Diagnostic

21- Positif

- posé par la douleur thoracique
- confirmé par les examens complémentaires (echo, scanner, IRM)

22- Différentiel

- clinique et ECG → IDM
- danger = fibrinolyse
- dissection = autres signes associés
- ETO ou Scanner redressent le diagnostic

3- Traitement

31- Buts

Médical:

- limiter l'extension de la dissection et éviter la rupture du cylindre externe
- contrôler la TA (PAS<120 mmHg)
- diminuer la douleur

Chirurgical:

- remplacer l'AO ascendante
- réséquer la porte d'entrée
- corriger une insuffisance aortique éventuelle

3- Traitement

32- Moyens

321- Médicamenteux:

- antalgiques majeurs (morphiniques)
- sédatif (benzodiazépines)
- hypotenseurs (PAS entre 100 – 110 mmHg)

LABETALOL Trandate*

1 mg / kg IV en 1 min

puis 0,1 mg / Kg / h

NICARDIPINE Loxen*

1 mg / min IV jusqu'à 10 mg

puis 2 – 4 mg / h

3- Traitement

32- Moyens

322- Chirurgicaux:

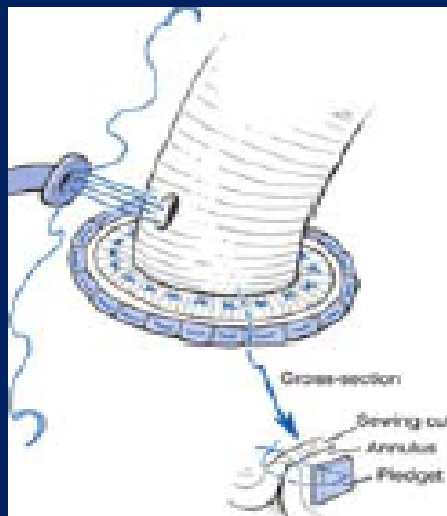
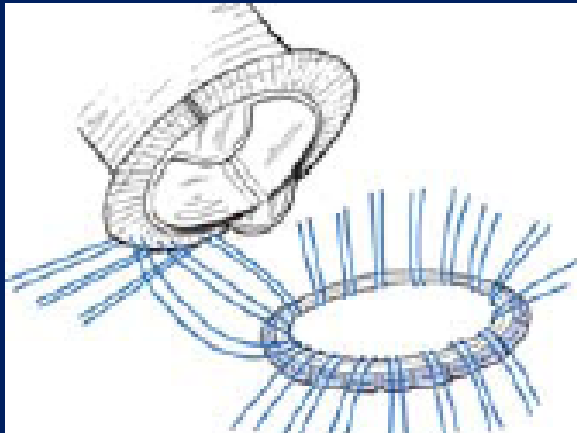
Opération de BENTALL

remplacement de l'aorte par une prothèse en Dacron

± correction de l'insuffisance aortique sous CEC

± réimplantation des coronaires

TRAITEMENT



3- Traitement

33- Indications

Dissection AO = URGENCE MEDICO-CHIRURGICALE

Type I et II:

- abord chirurgical plus facile
- risque de rupture +++
- Bentall (mortalité opératoire 15 – 20 %)

Type III:

- médical ++++
- abord chirurgical difficile (mortalité opératoire 50 – 60 %)
- collatérales +++ (artère médullaire)

Conclusion

- **Dissection aortique = affection grave (mortalité+++)**
- **Urgence médico-chirurgicale**
- **Maître-symptôme = douleur thoracique**
- **Traitement :**
 - type I et II = chirurgical**
 - type III = médical**